BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

QUY TRÌNH CHĂM SÓC BỆNH ÁP XE ỐNG TAI NGOÀI

Mã đề xuất CS-TMH-02; bản trình thẩm định 14/10/2026. Chưa ban hành. Biên soạn/thẩm định/phê duyệt: ……

Áp dụng chăm sóc điều dưỡng theo bệnh, gồm nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá. Kỹ thuật xâm lấn phải có quy trình riêng theo QĐ3023, chỉ định và người đủ phạm vi/năng lực; bộ này không cho phép điều dưỡng tự chẩn đoán hoặc quyết định điều trị.

ICD: H60.0

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh, lý do đến khám, khởi phát, bệnh nền, thuốc/dị ứng; đánh giá ABCDE, sinh hiệu, đau, ăn/nuốt, dịch vào-ra và nguy cơ té ngã theo tình trạng. Báo ngay khi khó thở, thở rít, tím, giảm ý thức, chảy máu nhiều hoặc dấu giảm tưới máu. Cận lâm sàng theo bác sĩ.

- Hỏi bệnh : Bệnh có ù tai, đau tai, chảy dịch tai, có ngoáy tai bằng vật cứng không ? Có đau tai về đêm không, đau khi nhai, khi ngáp, ấn nắp tai đau, kéo vành tai đau không? Có sốt không ?

Quan sát đau, đỏ, sưng, dịch và vùng quanh tai trong phạm vi chuyên môn; không ấn sâu vào ống tai để gây đau. Đái tháo đường, suy giảm miễn dịch hoặc đau dữ dội kéo dài cần bác sĩ đánh giá nguy cơ nhiễm trùng lan rộng.

Cận lâm sàng: Nội soi tai thấy áp xe gây bít hẹp 1 phần ống tai

2. Chẩn đoán điều dưỡng

2.1.Người bệnh ù tai, nghe kém do ống tai sưng

2.2.Người bệnh đau tai do khối áp xe

2.3.Nguy cơ xảy ra biên chứng nhiễm trùng tai

2.4.Người bệnh thiếu kiến thức về bệnh

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Xác định mục tiêu cá thể: giảm đau/triệu chứng, ổn định hô hấp và tuần hoàn, không xuất hiện dấu biến chứng; ăn/uống dung nạp và hiểu hướng dẫn. Ghi thời điểm đánh giá lại và người phụ trách.

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1.Giảm ù tai, nghe kém cho người bệnh

Thực hiện thuốc và chăm sóc theo y lệnh, kiểm tra tình trạng màng nhĩ/đường dùng thuốc. Rạch/dẫn lưu áp xe do bác sĩ hoặc người đủ phạm vi thực hiện theo quy trình riêng; điều dưỡng chuẩn bị và hỗ trợ.

4.2.Giảm đau cho người bệnh:

- Thực hiện thuốc giảm đau theo y lệnh, nhỏ thuốc tai, hướng dẫn người bệnh không tự ý nhỏ thuốc nam, không ngoáy tai.

4.3.Giảm nguy cơ nhiễm trùng tai:

- Vệ sinh tai sạch tại cơ sở y tế chuyên khoa, uống kháng sinh , kháng viêm , nhỏ tai theo y lệnh, không tự ý ngoáy tai móc tai

4.4.Cung cấp kiến thức cho người bệnh

Hướng dẫn đúng thuốc, giữ tai khô, không ngoáy tai hoặc tự nhỏ thuốc. Tái khám theo lịch đã ghi, không chờ hết thuốc khi đau tăng, sốt, sưng lan hoặc giảm thính lực.

5. Đánh giá

-Người bệnh cải thiện

- Hết ù tai, nghe được, tai hết sưng

- Bệnh hiểu biết về bệnh

Ghi kết quả theo từng mục tiêu, triệu chứng/sinh hiệu trước và sau, mức ăn uống và nhu cầu hỗ trợ; điều chỉnh kế hoạch khi chưa đạt hoặc có vấn đề mới. Không ghi chung “khỏe hơn” để thay giá trị theo dõi.

Ghi chép bàn giao và hướng dẫn sau chăm sóc

Ghi nhận định, vấn đề, mục tiêu, thuốc/can thiệp, đáp ứng và thời điểm báo bác sĩ; bàn giao ISBAR, nơi và người tiếp nhận khi chuyển. Hướng dẫn đúng đơn, lịch tái khám cụ thể và dấu nguy hiểm; yêu cầu người chăm sóc nhắc lại. Không đợi hết thuốc khi có dấu xấu đi.

Căn cứ và nội dung cần xác nhận

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . QĐ3023/QĐ-BYT dùng cho đề cương kỹ thuật khi có quy trình kỹ thuật riêng, không dùng để xác lập mọi can thiệp chăm sóc bệnh lý.

Khoa TMH xác nhận chẩn đoán/mã ICD, danh mục kỹ thuật được phép, thuốc và kế hoạch theo dõi theo tuổi. Các chẩn đoán điều dưỡng trong nguồn là gợi ý, chỉ chọn khi có dữ liệu thực tế; không mặc định mọi người bệnh đều có tất cả vấn đề.

Người thẩm định/chữ ký/ngày: …… Số quyết định/ngày hiệu lực: ……